

13. AXE CRANIO SACRÉ PRIMITIF

DURÉE : 03:34

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, nous explorons en profondeur l'axe cranio-sacré primitif, qui émerge lors de la deuxième semaine du développement embryonnaire avec la formation de la notochorde. L'enseignement met en lumière l'importance de cette structure pour le crâne et le sacrum, notamment en soulignant comment un sacrum libre est essentiel pour assurer la fonctionnalité de la colonne vertébrale et la flexion-extension de la base du crâne. En outre, la vidéo traite des implications que ces dynamiques embryonnaires ont sur les pathologies urogénitales, et comment la libération de certains blocages émotionnels ou énergétiques entre le sigmoïde et la vessie peut contribuer à un meilleur équilibre global. Les étudiants apprendront à manipuler ces concepts pour améliorer leur pratique en ostéopathie et en embryologie biodynamique.

AXE CRANIO-SACRÉ PRIMITIF

Au cours de la deuxième semaine de développement embryonnaire, la **forme en S** du processus épiblastique commence à former la **notochorde**.

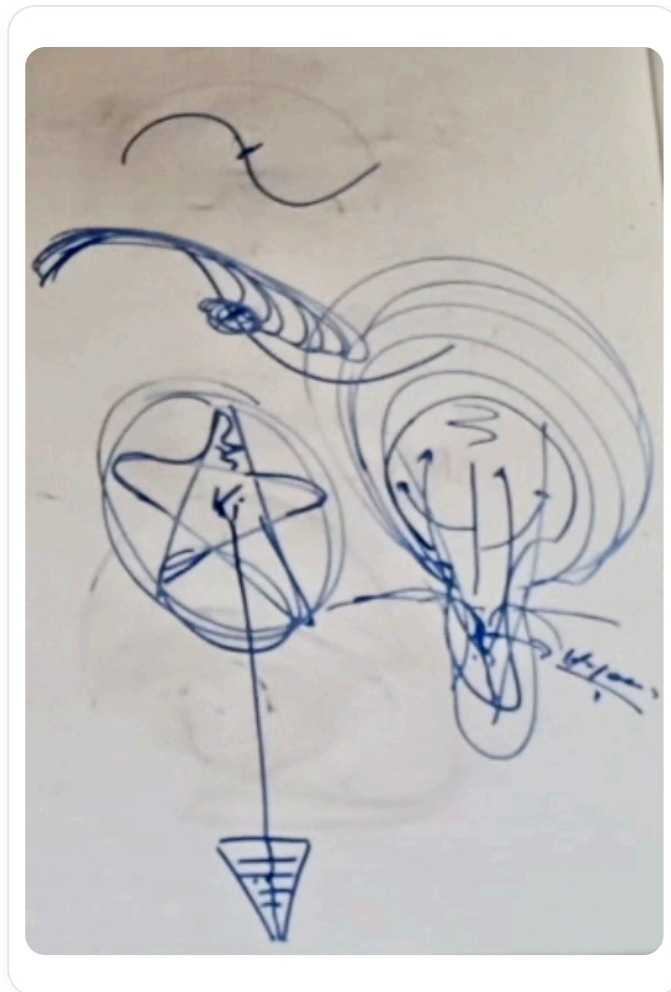


FIG. — Début du processus épiblastique

Le **nœud de Hensen**, ou dépression primitive, devient un point d'appui fixe et se déplace progressivement vers l'arrière.

Cette structure est essentielle car elle constitue la base du **crâne**, intégrant des éléments comme l'**hypophyse**, les **grandes ailes du sphénoïde**, le **système pétreux**, le **système occipital** et l'**ethmoïde**. En bas, le développement du **sacrum** commence, avec le processus de S2, qui représente le vestige de la ligne primitive. Ce processus devient un point d'appui crucial, soulignant l'importance d'un **sacrum libre** pour permettre une unité fonctionnelle.

Dans cette phase de développement, l'embryon prend une forme semblable à une raquette, avec la notochorde et la ligne primitive. Ce processus de croissance génère un champ d'aspiration pour former le **mésoderme**, notamment le champ précardiaque. La croissance antérieure de l'embryon aspire le matériel dans cette zone, entraînant des cellules en forme de **bottle cells** vers le centre. Ces cellules libèrent de l'**acide hyaluronique**, essentiel au niveau mésenchymateux.

L'axe notochordal est fondamental, car il influence la liberté de mouvement du sacrum. Si le sacrum est bloqué, la colonne vertébrale ne peut pas fonctionner correctement, ce qui affecte la base du crâne. Une base du crâne non libre empêche une bonne **flexion-extension**, entraînant un déséquilibre entre le **neurocrâne** et le **viscérocrâne**.

Cette dynamique est liée à la force d'ascension du crâne, où l'œil s'installe, et à la mise en place d'un **tissu mésodermique**. La croissance ectodermique tire vers le haut, tandis que le nœud primitif descend vers le sacrum. Cela crée une zone d'importance pour l'information protéinique en relation avec la mère.

De nombreuses **images ancestrales** bloquées se situent entre le sigmoïde et la vessie, où il est crucial de dégager ces informations. Les problèmes urogénitaux peuvent être transmis par ces informations, et la force de migration descendante sacrale joue un rôle clé dans ce processus.